جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ولاء عيد علي محمد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** روض الفرج **العنوان :** روض الفرج
رقم البطاقة : 27906040101684 **رقم التليفون :** 01110050101 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 04-06-1979 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ولاء عيد علي محمد
National ID: 27906040101684

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لصحة المرأة المصرية

MDT FORM 17/12/2024

Name		MRN	
Age	45 y.	ID	
Menopausal status	premenop	Phone	
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: IDC.

ER: +ve 5/8	PR: +ve 6/8	HER 2: 3+	KI67:

R

Sonomammography: premenop. left Breast C12, N2, M0 by rad.

Mets Workup: Pt Rc. TCHP x 6 on 11/11/2024 → Left simple Mastect, + ALND

TNM

ypT1c1 ypN0 0/11

Recommendations: Rad Rx to Rt Breast

MDT OUTCOME & PLAN for continue Adjuvant phesgo to complete 1Yr, start Adj Arbumalax PORT Zoladex

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: ولاء عيد علي محمد **MR. :** 4903	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 46-year-old individual with a left breast mass initially staged as cT2N2. Hormone receptor testing showed estrogen receptor 5/8, progesterone receptor 6/8, and HER2 3+. Neoadjuvant chemotherapy with the TCHP regimen was administered, followed by a modified radical mastectomy in November 2024, which revealed TisN0 disease. Post-operative therapy included completion of anti-HER2 treatment and ongoing endocrine therapy with Arimidex and a GnRH agonist (Zoladex) initiated in December 2024. The most recent breast MRI performed in November 2025 demonstrated no residual disease. The patient received Arimidex on the day of the visit, and the next Zoladex injection is scheduled for 10 April.

The patient was evaluated in April 2026 and found to have a calcified gallbladder and a small uterine fibroid. Current medications include Arimidex and Zoladex, with supportive care planned for the next three months. The next follow-up appointment is scheduled for 10 October 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Visit Number	060245075926		
Patient Name		Client Name	
Age / Sex	44 year / Female	Referred By Prof	Ahmed Saqr
Patient ID	2134431416 Acc.988418	Exam Date	09 May 2024 09:00
		Printed	11/05/2024 11:01:14 AM

PT

Whole Body PET/CT Examination

History and Clinical Data: -

Patient data: -

- **Lady patient, 44 years old, Weight: 63 Kg, Height: 158 cm, Blood Glucose level: 105 mg/dl.**

Radiopharmaceutical: -

F-18-FDG 5.9mCi injected I.V.

Clinical background: -

- **Patient with recent diagnosis of left breast carcinoma (infiltrating duct grade II).**

Purpose of the study: -

- **Initial study for metastatic workup**

TECHNIQUE: -

- Approximately one hour following the IV injection of the radio-pharmaceutical, a total body PET-CT was acquired from the mid-thigh to the base of the skull with arms extended above the head. CT was acquired for the purpose of anatomic localization, attenuation correction and diagnostic purpose.
- Data was processed and displayed according to departmental protocol.
- Adequate liver and brain FDG uptake with adequately co-registered PET and CT images.
- **Liver showed average SUV ~2.17 (max. SUV~2.83).**

REPORT: -

Review of the PET, CT and the fused images revealed:

I) **Loco regional (breasts and axillae):**

1. **Left side:**

- Metabolically active (FDG avid) soft tissue mass lesion is seen in the upper inner quadrant, measuring about 2.1 x 2.5 cm in maximum axial diameters and achieving max. SUV~13.96.
- Enlarged hyper-metabolic axillary lymph node measure about 1.2 x 2.8 cm with max~SUV~13.58.

Other smaller low-grade metabolically active axillary LNs are seen as well showing preservation of the fatty hilum, nonspecific.

- **Right side:**

No metabolically active (FDG avid) parenchymal soft tissue mass lesion detected.

PET Scan
[[DOCTYPE:PET_SCAN]]

CAIRO SCAN

DETAILED FINDINGS:

LEFT BREAST:

- Predominant fibroglandular pattern. (ACR C)
- UIQ area of asymmetry with underlying uncircumscribed isodense mass & regional suspicious microcalcifications
- Additional U/S depicted UIQ parareolar at 10 o'clock uncircumscribed irregular shaped hypoechoic mass with relatively echogenic rim , showing some peripheral vascularity , multiple echogenic foci , measures 21x11.5 mm , the surrounding parenchyma is heterogenous with foci of microcalcifications , ? infiltrated
- Multiple variable sized simple cysts about 3 mm
- Normal skin/nipple/areolar complex
- Pathologically enlarged axillary lymph nodes , showing focal increase in cortical thickness reaching 7.5 mm

RIGHT BREAST:

- Predominant fibroglandular pattern. (ACR C)
- No dominant masses, spiculations or suspicious microcalcifications
- Additional U/S depicted normal parenchymal echogenicity with no solid lesions seen multiple variable sized cysts , largest retroreolar (19.5x7.5 mm)
- No definite signs of malignancy detected
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Preserved axillary lymph nodes are seen

Best regards,
DR/SHEREEN ALI,
FEBR

For any inquiries regarding the findings in the report please contact us on radreport@cairoscan.com.eg

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT

الهيئه العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهه الاصدار :فرع القاهرة

رقم الاستمارة 20 وثيقة

تاريخ الاصدار :2024-4-30

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال أو لئين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التامينات الاجتماعيه

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين ان

السيد (ة) ولاء عبد على محمد بطاقة رقم 27906040101684

وطبقا الى خطاب من التامينات الاجتماعية بابد عدم الانتفاع بغير من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتامين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التامين الصحى الشامل

وشكرا

ن وظف المختص
ايمان عبد الحميد

تاريخ الطباعه :2024-4-30

ادارة مركز نظم المعلومات
يعتمد...

مستقبل 1321057

هذا الخطاب صالح لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الاصدار الا فى حاله تغير حاله المواطن مع قبل الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية و وزارة التضامن الاجتماعى او وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Non-UHIA Letter
[[DOCTYPE:NON_UHIA_LETTER]]

Imaging report

CAIRO SCAN

Name : Mrs. Walaa Eid Ali Mohamed

Date : 13/04/2024
Room Name : Mammography-Sh

Code : 3029298

COMPUTED DIGITAL MAMMOGRAPHIC EXAMINATION OF BOTH BREASTS:

CLINICAL SUMMARY:

Age: 45 years old, left parareolar palpable breast mass

IMPRESSION:

LEFT BREAST: (BIRADS 4c)

- UIQ parareolar suspicious mass , suspicious microcalcifications , pathologically enlarged axillary lymph nodes

RIGHT BREAST: (BIRADS 2)

- Simple cysts

RECOMMENDATION:

Biopsy from left breast mass , MRI to detect actual extension , role out multicentricity & multifocality .

TECHNIQUE:

Craniocaudal & Mediolateral Oblique views
High resolution Ultrasound with Color Doppler

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	: الأستاذ / ولاء عبد على محمد		
Patient No.	: 27906040101684	Request No.	: 13005106
Path No.	: SR-545/24	Request Date	: 01/05/2024
Sex	: Female	Verification Date	: 07/05/2024
Age	: 44 Y	Financial Category	: نقدية الورقة
Referreing Doc :		Department	: Out Patient
		Registered by	: manwa mohamed youss

Pathology Report

· Ki67: Positive in 50% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
Scoring system: "Her2"
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

SIGNATURE
Dr.Rana Fathy
Dr.Muhammad Torkey

Verified by :
Dr.Mohamed Torky

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الآنسة / ولاء عبد على محمد		
Patient No.	: 27906040101684	Request No.	: 13005106
Path No.	: SR-545/24	Request Date	: 01/05/2024
Sex	: Female	Verification Date	: 07/05/2024
Age	: 44 Y	Financial Category	: تنقية الدولة
Referreing Doc :		Department	: Out Patient
		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

CLINICAL DATA
Left breast cancer

NATURE OF SPECIMEN
Block and slides revision

GROSS PATHOLOGY
One paraffin block labeled 841786 and 5 slides

HISTOPATHOLOGY
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Ductal carcinoma in situ: No
- Perineural invasion: No
- Angioinvasion. No
- IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Moderate nuclear reaction in 20% of tumor cells (score 5/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 20% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+)
- Ki67: 50% nuclear reaction of tumor cells.

DIAGNOSIS
-oft breast mass, Block and slides revision:
nvasive duct carcinoma, Grade II.
PT:
ER: Positive (score 5/8).
PR: Positive (score 6/8).
Her2: Positive (score 3+).

Verified by :
Dr.Mohamed Torky

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]